Здравоохранение России глазами пациента

SKOLKOVO
Moscow School
of Management

Центр развития
здравоохранения

Преамбула

Согласно указу Президента Российской Федерации №474 от 21 июля 2020 года в настоящее время в здравоохранении существуют две глобальные национальные цели - повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и повышение удовлетворенности населения медицинской помощью.
«Пациентоцентричность» - это новое и главное направление требований Росздравнадзора по организации внутреннего контроля качества в медицинских организациях и подразумевает формирование медицинских услуг исходя из запросов пациента и партнерскую позицию общения между врачом и пациентом.

В системе здравоохранения Российской Федерации 85% оказанных медицинских услуг приходятся на государственный сегмент ОМС. Остальные услуги чаще оказываются по каналу платных медицинских услуг (ПМУ) и реже через сегмент ДМС . Различные сегменты системы здравоохранения несут в себе различные функции, но у них есть связующее звено - пациенты, их удовлетворенность, ожидания и опыт. Путь пациента не ограничивается одним сегментом, а может сочетать в себе и несколько вариантов совмещения сегментов здравоохранения.
Для построения плана по совершенствованию системы здравоохранения целесообразно проанализировать путь пациента от момента проявления проблемы до ее возможного решения. Четкое понимание профиля пациента и его потребностей, для которых формируется сервис, поможет совершенствовать пациентоцентричность отрасли.

Материалы и методы исследования

Качественный этап

- Онлайн-интервью по методике Path Finder
- 17 глубинных интервью
- Длительность до 2,5 ч.
- Москва

Количественный этап

- Количественный опрос по формализированной анкете
- 1509 интервью (мужчины и женщины в возрасте 35–65 лет)
- Январь 2024 г.
- Города с населением >500тыс человек

Цели и задачи исследования

Оценить восприятие системы здравоохранения (СЗ)

Выявить основные барьеры и зоны дальнейшего совершенствования в процессе взаимодействия пациента и СЗ

Определить особенности использования программ ОМС, ДМС, платных услуг;

Оценить соответствие СЗ принципам пациенто-центричности

Выявить уровень удовлетворенности пациентов при взаимодействии с СЗ в зависимости от сегмента (ОМС, ДМС, ПМУ) и их совмещения

Оглавление отчета

1. Путь пациента **6**
a. Распределение нагрузки на систему здравоохранения 7
b. Платные медицинские услуги. Совмещение сегментов 11
c. Диспансеризация 16
2. «Идеальная» картина системы здравоохранения **19**
a. Условия идеального визита к врачу 23
b. Что такое «хороший» врач? 24
3. Соответствие работы системы здравоохранения ожиданиям **25**
a. Восприятие работы системы здравоохранения 26
b. Оценка системы здравоохранения 31
4. Понимание пациентоцентричности **34**
a. Пирамида потребностей пациента 35
b. Эмоциональное состояние пациентов 36
c. Сегментация 37
5. Выводы исследования **41**

Путь пациента

Бесшовный переход

В ОМС это максимально удобно сделано, не нужно ни выписок носить, ни талонов, результаты анализов тоже в карте довольно быстро. Но если обращаться к врачу в другой клинике, то нужно все распечатывать и нести с собой.

Пациентка,
сахарный диабет

Диспансеризация

Врачи стали отвечать на вопросы и стали рекомендовать что-то. С ними можно теперь и поделиться и обсудить что-то и они неформально работу свою выполняют. До этого диспансеризация была исключительно формальной.

Пациент,
профилактическое обращение

Платные услуги

Изначально я пошла бесплатно к гинекологу и она выписала мне направление на УЗИ, но я не стала ждать несколько недель, потому что врач очень сильно напугала меня возможным диагнозом. На нервах я пошла в платную клинику, чтобы сразу это опасение либо подтвердить, либо снять.

Пациентка,
онконастороженные

В бесплатной медицине запись к хорошему врачу заполнена на месяц вперед.

Пациент,
профилактическое обращение

Распределение нагрузки на систему здравоохранения (1/4)

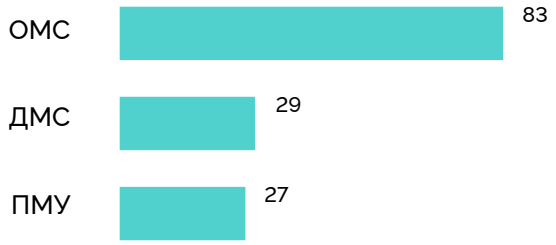
Большая часть нагрузки (83%) в СЗ приходится на сектор ОМС. В меньшей степени, но относительно равноценной, пациенты пользуются услугами ДМС (29%) и ПМУ (27%).

Основной целью посещения врача у большего количества пациентов является лечение или контроль острого или хронического заболевания (77%). Пациенты реже обращаются для профилактического осмотра и диспансеризации (42%). Обращает на себя внимание, что для лечения обострения хронического заболевания пациенты обращаются чаще, чем для его контроля.

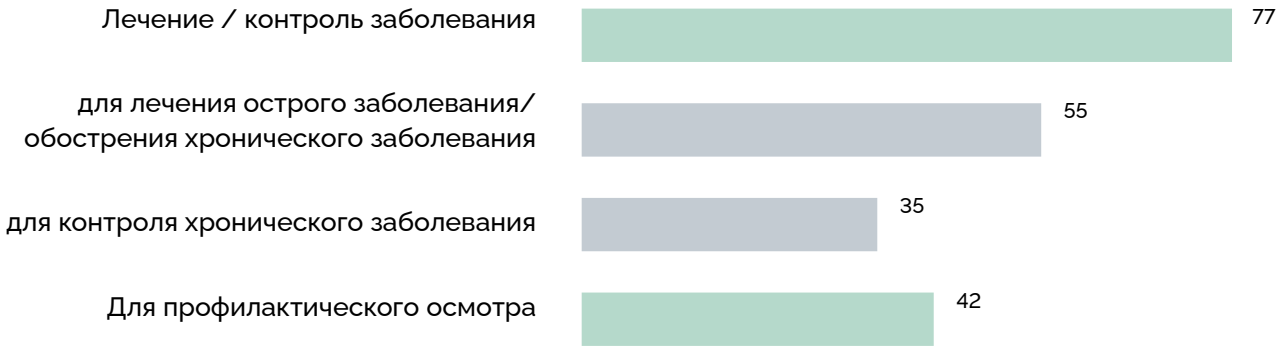
73%

пациентов обращались к амбулаторному врачу за последние 12 месяцев

Тип обращения к врачу, %



Цель обращения к врачу, %

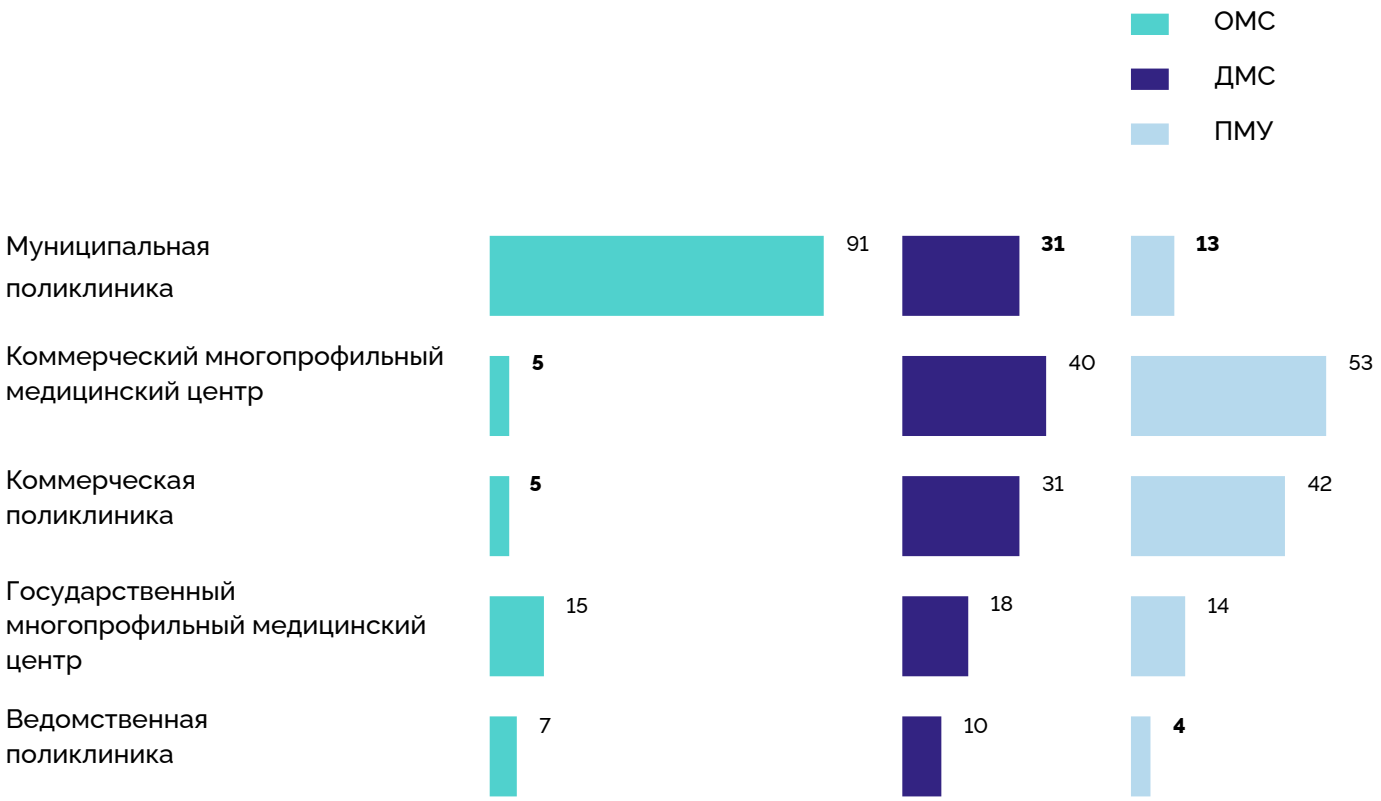


Распределение нагрузки на систему здравоохранения (2/4)

По ОМС абсолютное большинство обращается в городские поликлиники (91%) и реже в государственные центры (15%).

В случае с ДМС большую часть обращений составляют коммерческие учреждения (40% медицинские центры и 31% поликлиники), но пациенты также активно пользуются услугами государственных учреждений (32% поликлиника и 18% медицинский центр).

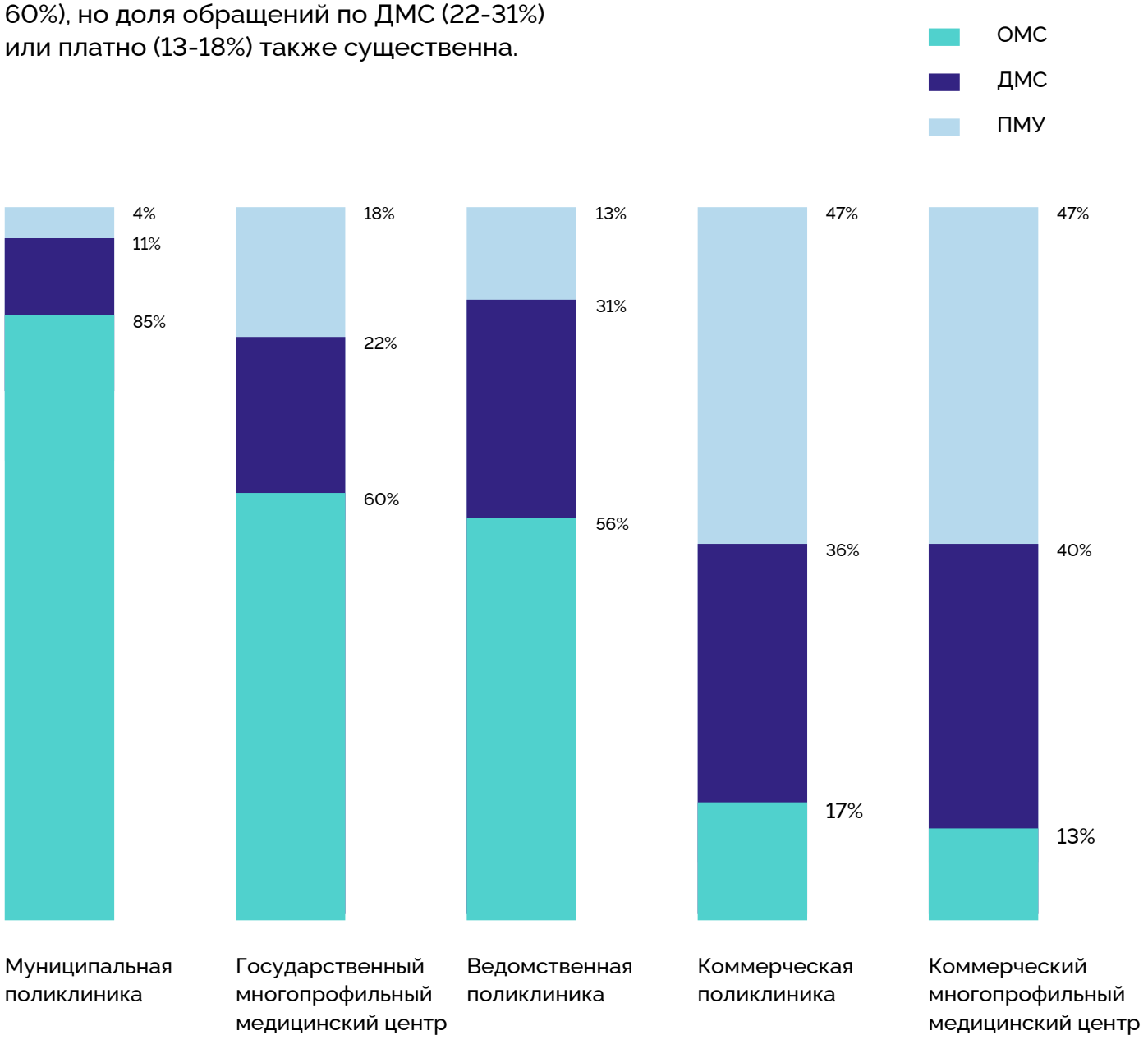
По ПМУ большая часть обращений обходится на коммерческие центры (53%) и поликлиники (42%).



Распределение нагрузки на систему здравоохранения (3/4)

Абсолютное большинство обращений в муниципальные поликлиники – по ОМС (85%), в коммерческие ЛПУ обращаются чаще платно (47%) или по ДМС (36-40%).

Промежуточная ситуация наблюдается у государственных центров и ведомственных поликлиник - превалирует ОМС (56-60%), но доля обращений по ДМС (22-31%) или платно (13-18%) также существенна.



Распределение нагрузки на систему здравоохранения (4/4)

В структуре обращений острые и хронические проблемы имеют примерно одинаковый вес, 59% и 51% соответственно.

Наиболее частыми поводами для обращения среди острых состояний являются - ОРВИ (32%) и травмы (12%), а среди хронических заболеваний - гипертоническая болезнь (15%) и заболевания суставов (13%).

Платные медицинские услуги (1/2)

Большая часть пациентов (57%) обращались за платными медицинскими услугами, в частности для получения анализов (48%), УЗИ (40%) и рентгенологических исследований (26%). Основными причинами обращения за услугами ПМУ являлись слишком долгое ожидание бесплатной услуги (54%), отсутствие этих услуг по системе ОМС (22%) или повышенное качество платных лабораторных или диагностических методов исследований (19%).

57%

взрослых 35-65 лет в городах 500тыс+ оплачивали медицинские услуги за последние 12 месяцев

Какие услуги оплачивали, %

Почему оплачивали, %

Платные медицинские услуги (2/2)

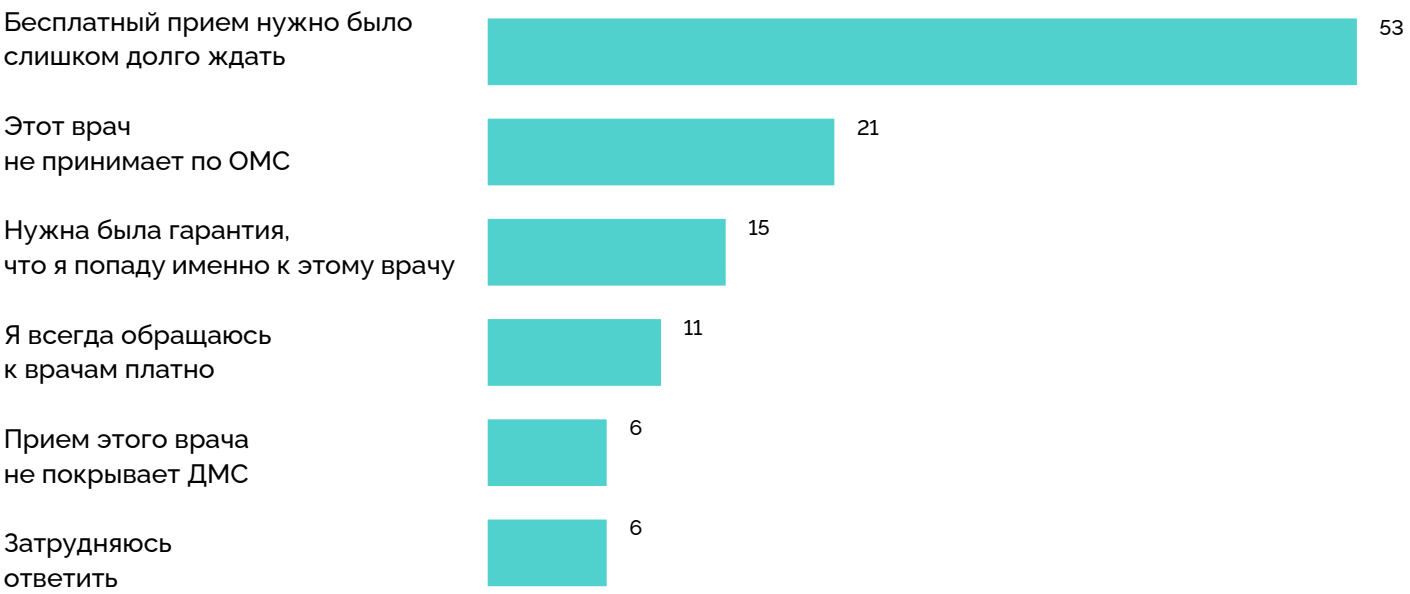
Основной причиной обращения к врачу по ПМУ является - долгое ожидание (53%), как и в случае с диагностическими процедурами. В меньшей степени отсутствие приема по ОМС (21%) и уникальность врача (15%).

По ОМС пациенты в основном обращаются к терапевту (54%), реже к узким специалистам (0-8%).
По ДМС - как к терапевту (44%) так и к узким специалиста (0-10%), в частности гастроэнтеролог и ЛОР-врач.
По ПМУ – это по большей части визиты именно к врачам узких специальностей (1-21%), к терапевту количество посещений значимо меньше (13%).

27%

среди обратившихся к врачу хотя бы один раз за 12 месяцев оплачивали визит

По какой причине визит оплачивался, %



Совмещение сегментов С3 (1/3)

Каждый пятый пациент совмещает типы страхования в рамках одного заболевания, что вызвано проблемами с ожиданием диагностики (37%), упрощенной записью на диагностические исследования по ДМС/ПМУ (29%), недоступностью врачей (28%)/диагностики по ОМС (27%) и реже для получения второго мнения (25%).

Наиболее частый способ совмещения услуг - ОМС + платная диагностика(39%) или визиты к врачу (29%), еще реже ОМС + ДМС (20%).

21%

использовали несколько способов страхования / оплаты при лечении одного заболевания

Тип совмещения, %

Причины совмещения ОМС и ДМС / платных услуг, %

Совмещение сегментов С3 (2/3)

В целом, сегмент ОМС нельзя назвать проактивным в вопросе перехода между сегментами, менее половины пациентам (44%) дают рекомендации о возможных способах получения услуг.

Муниципальная поликлиника более активна в вопросе обеспечения бесшовного перехода в коммерческий сегмент в маленьких городах (59%), а в столице чаще помогает в случае самостоятельного обращения пациента за помощью (23%). Тем временем в средних городах муниципальная поликлиника остается самой «неотзывчивой» и пациентам требуется самостоятельно искать способы получения медицинских услуг (50%).

Маршрутизация при совмещении, %	ВСЕ	МОСКВА	1МЛН+	500 – 999ТЫС
В муниципальной поликлинике мне дали рекомендацию куда обратиться платно/по ДМС	44	40	37	**59**
Мне не давали рекомендаций в муниципальной поликлинике, куда обратиться платно/по ДМС, пришлось самостоятельно искать	40	32	**50**	31
Мне не давали рекомендаций в муниципальной поликлинике, куда обратиться платно/по ДМС, но когда я спросил совета, помогли разобраться	12	**23**	9	8

Совмещение сегментов С3 (3/3)

Информация между системами передается без особых проблем, но чаще всего на физических носителях. Наиболее часто передается информация с результатами инструментальной (72%) и лабораторной (63%) диагностики, реже заключение врача (48%) и выписка из стационара (18%). Пациенты в целом склонны оценивать опыт передачи как легкий, не сопровождающийся трудностями, но при этом каждый пятый пациент сталкивался с потерями информации.

22%

заявляют, что информация терялась в процессе передачи из одной системы страхования в другую

60%

имели необходимость передать информацию от врача из одной системы страхования в другую

Какую?, %

Как?, %

Диспансеризация (1/3)

Каждый третий пациент обращается к системе здравоохранения для профилактического осмотра. Пациенты чаще выбирают самостоятельно посещать только тех специалистов, которых они считают нужными (67%) и реже пользуются программами диспансеризации (13-38%).Городская программа добровольной диспансеризации активнее работает в Москве (50%), по сравнению с остальными городами (29-35%).

30%

взрослых 35-65 лет в городах 500тыс+ обращались к амбулаторному врачу за последние 12 месяцев **для профилактического осмотра**

Тип профилактического обращения к врачу, %

	ВСЕ	МОСКВА	1МЛН+	500–999ТЫС
Ходил(а) к отдельным специалистам, к которым считаю нужным ходить	67	72	63	66
Добровольная диспансеризация, по городской программе	38	**50**	35	29
Обязательная диспансеризация / Для медкнижки	19	16	22	19
Добровольная диспансеризация, по направлению работодателя	13	14	14	10

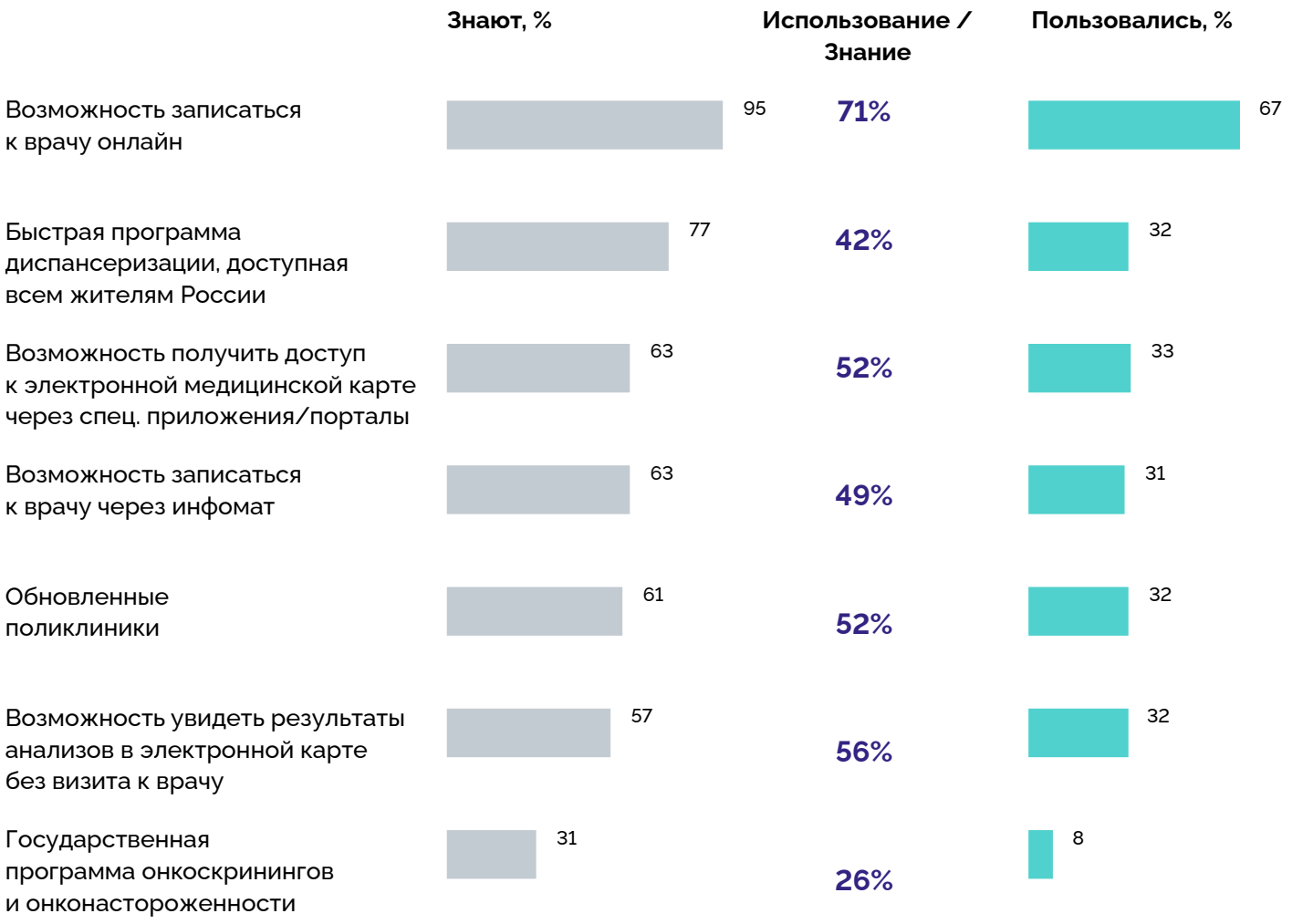
Диспансеризация (2/3)

Пациенты ниже оценивают обязательную диспансеризацию (54%), в особенности вовлеченность врача (53%) и легкость записи (46%), в отличие от самостоятельной диспансеризации (76%), где пациент может выбрать необходимых специалистов и диагностические исследования. Добровольная городская диспансеризация имеет среднюю оценку не только удовлетворенности (57%), но и вовлеченности врача (66%) и легкости процесса записи (53%).

	Обязательная диспансеризация	Добровольная, по направлению работодателя	Добровольная, по городской программе	Самостоятельная диспансеризация
Удовлетворенность в целом, ТОП-2 %	**54**	63	**57**	76
Врач вникает в проблему	**53**	58	66	**79**
Врач подбирает индивидуальное лечение	62	56	71	69
Врач хорошо информирует	53	71	62	67
Доброжелательные тональность и стиль общения	67	67	73	84
Врач объясняет важность комплаентности	53	60	63	72
Наличие необходимого оборудования	53	69	62	**76**
Легкость процесса записи	**46**	62	53	69
Доступность записи и направлений	52	75	60	71
Хорошая работа регистратуры при визите	62	71	66	76
Эффективная реакция администрации на обращения	46	54	62	59
Хорошая работа немедицинского персонала	68	78	67	75
Скорость получения услуги	56	64	64	67

Диспансеризация (3/3)

Инициативы, направленные на профилактические осмотры, требуют дополнительных усилий по популяризации. Программа быстрой диспансеризации по ОМС достаточно известна (77%), однако пользуется ей меньше половины знающих людей (42%). Еще хуже ситуация с профилактикой злокачественных новообразований, о ней знают лишь треть пациентов (31%) и даже те немногие, кто знает о ней, не пользуются.



«Идеальная» система здравоохранения

«Идеальная» картина для пациентов выглядит следующим образом: комфортная современная дружелюбная клиника и «семейный» врач, который ведет пациента много лет

Идеальный врач — тот, к которому хочется ходить постоянно

Это и профессионализм, и выяснение тонкостей, и налаживание диалога в момент, когда он тебя опрашивает. Даст дельный совет именно тебе, что-то вроде семейного доктора, который знает всю твою историю, не штампует одни и те же назначения, не вникая, а нужное именно тебе. Который полно отвечает на все вопросы и не раздражается от них. Ровный, нейтральный, спокойный, деловой.

Пациент,
профилактическое обращение

Идеальный врач все время учится

Цена ошибки врачебной сейчас очень велика. Это прямо вот моя жизнь. Хотелось бы от них высокой квалификации, или хотя бы научного подхода, чтобы они не просто сидели и отсиживали свое место. Они там уже три года назад отучились на последних курсах, и здесь они просто работают, и больше ничего не читают по своей теме, не интересуются, потому что им некогда.

Пациент,
профилактическое обращение

Идеальная клиника – место, куда приятно прийти и где помогут

Светлое учреждение, где повышается настроение и улучшается самочувствие, понимаешь, что тебе тут помогут. Дружелюбные, отвечают на все твои вопросы, дольше выслушивают и более охотно дают рекомендации.

Пациент,
профилактическое обращение

«Идеальная» система здравоохранения (1/3)

Опыт взаимодействия в первую очередь зависит от возможности получить услугу доступно и быстро, от общения с врачом (отзывчивость, подобранное лечение, доброжелательность) и от наличия необходимого оборудования.

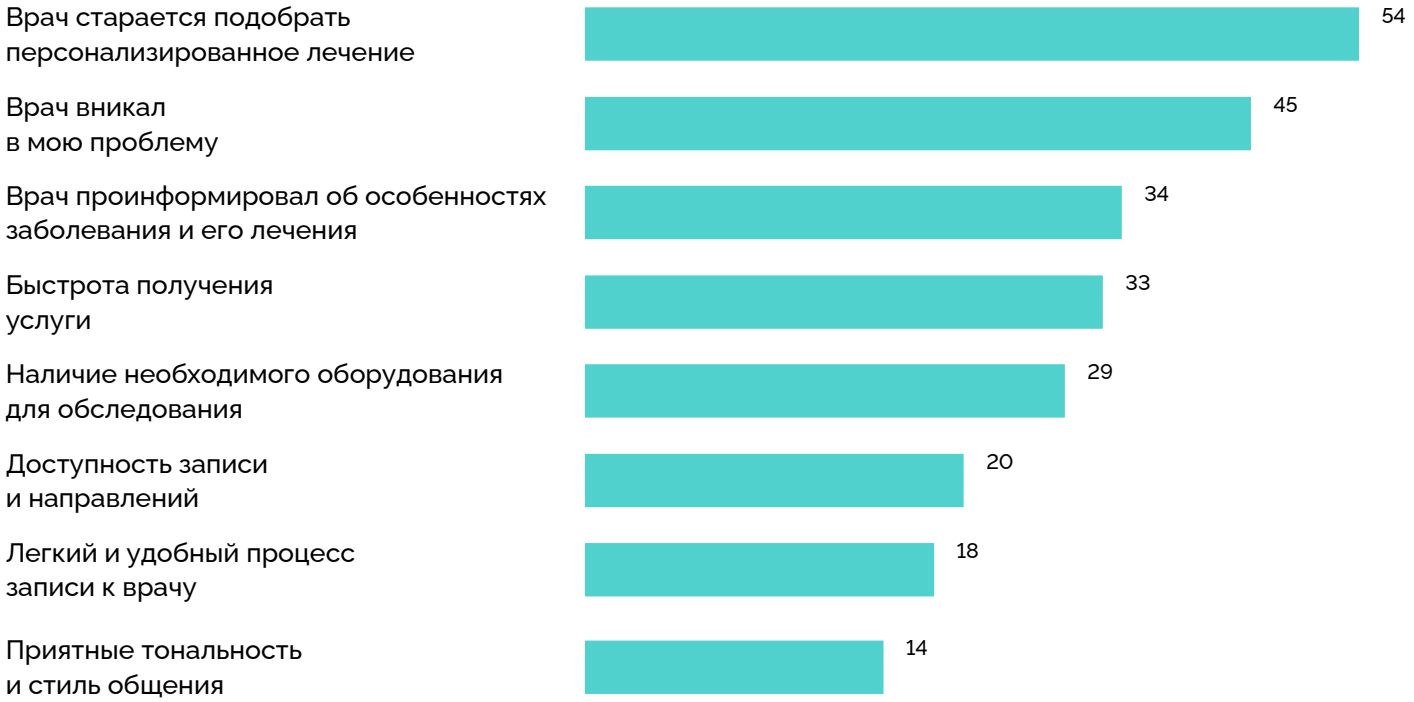
Только при соблюдении этих условий пациент начинает обращать внимание на дополнительные услуги, электронные сервисы, работу немедицинского персонала и навигацию в ЛПУ.

~9

условий должно выполняться, чтобы визит к врачу назвали идеальным

«Идеальная» система здравоохранения (2/3)

При опросе пациентов о трех наиболее важных условиях для идеального визита главным актором системы становится «хороший» врач, и менее важны скорость получения медицинской услуги и необходимое оборудование для обследования. Без удовлетворения трех важных условий технические аспекты взаимодействия с системой здравоохранения не играют существенной роли.



«Идеальная» система здравоохранения (3/3)

Выявленная и заявленная важность условий практически полностью совпадают. Комплаентность – единственный атрибут, который пациенты недооценивают, а скорость и доступность получения услуги на самом деле не являются значимым фактором.

Врач — лицо системы здравоохранения

Рациональное восприятие:

система лечебных учреждений и работающие в них врачи.

Эмоциональное восприятие:

спасает и вызывает доверие как надежная система, но одновременно поддерживает в пациентах страхи и тревогу, может усугублять страдания тяжелых пациентов.

С точки зрения пациентов

Система здравоохранения сейчас не воспринимается как заботящаяся о здоровье и помогающая им управлять, а как инструмент решения уже возникшей острой или серьезной проблемы

Медицина это помощь. Место, где меня приведут в нормальное состояние. Это реальная помощь при возникновении какой-то ситуации. Квалифицированные специалисты, знающие, обладающие соответствующим образованием, чтобы помогать.

Пациент, профилактическое обращение

Неприветливая. Спасет, но не позаботится.

Пациент, кардиозаболевание

Обновленные поликлиники я представила – светлые, красивые, чистые – не хуже, чем любая из коммерческих. Собянинские программы диспансеризации.

Пациент, сахарный диабет

«Хороший врач» = эмпатичный, компетентный, вежливый врач

Врач вникает в проблему	18.29
Врач подбирает индивидуальное лечение	10.99
Врач хорошо информирует	10.28
Тональность и стиль общения	8.11
Врач объясняет важность комплаентности	6.93
Наличие необходимого оборудования	5.06
Легкость процесса записи	3.89
Доступность записи и направлений	3.80
Работа регистратуры при визите	3.80
Реакция администрации на обращения	3.49
Работа немедицинского персонала	3.09
Скорость получения услуги	2.91
Электронная очередь	2.77
Работа регистратуры по телефону	2.66
Информация в ЛПУ	2.57
Навигация внутри ЛПУ	2.36
Физическая доступность	2.10
Приложение для смартфона	2.04
Обеспечение расходниками	1.90
Качество ремонта	1.28
Дополнительные услуги	0.87
Доступ к электронной карте	0.80

Соответствие работы системы здравоохранения ожиданиям

Основная поддержка большинства пациентов - ОМС, вызывающая доверие, дающая больше возможностей и всегда доступная. «Она есть всегда и не может закончиться, как рабочая страховка, помогут в любом случае»

Однако ни одна страховка не может дать гарантий быть комфортной и удобной, все зависит от условия конкретных клиник и компетенций врачей.

ОМС: надежно, доступно, но неудобно и долго

- Система, которая работает много лет и поэтому вызывает большое доверие
- Доступная для обращения с любыми медицинскими проблемами
- Охватывает большую часть необходимых дорогостоящих обследований и услуг
- Но не всегда удобная, не всегда комфортная и требующая долгого ожидания ряда медицинских услуг.

ПМУ: быстро и «комфортно, но за большие деньги»

- Наиболее быстрый и доступный вариант получения медуслуг в любом варианте, комфорт и сервис, доброжелательное отношение
- Большее количество узких специалистов
- Не всегда нужные визиты и обследования за высокую цену – «навязывание услуг» (мнение части пациентов).

ОМС: надежно, доступно, но неудобно и долго

- Чаще предоставленная работодателем, реже – приобретенная самостоятельно
- Более удобный и быстрый доступ к врачам и обследованиям, не нужно ждать. Проводится в частных клиниках с хорошим сервисом.
- Но многое нужное пациенту не входит в программу, необходимо согласование со страховой компанией. Усредненная система, не учитывающая специфические проблемы, маленький выбор доступа к узким специалистам.

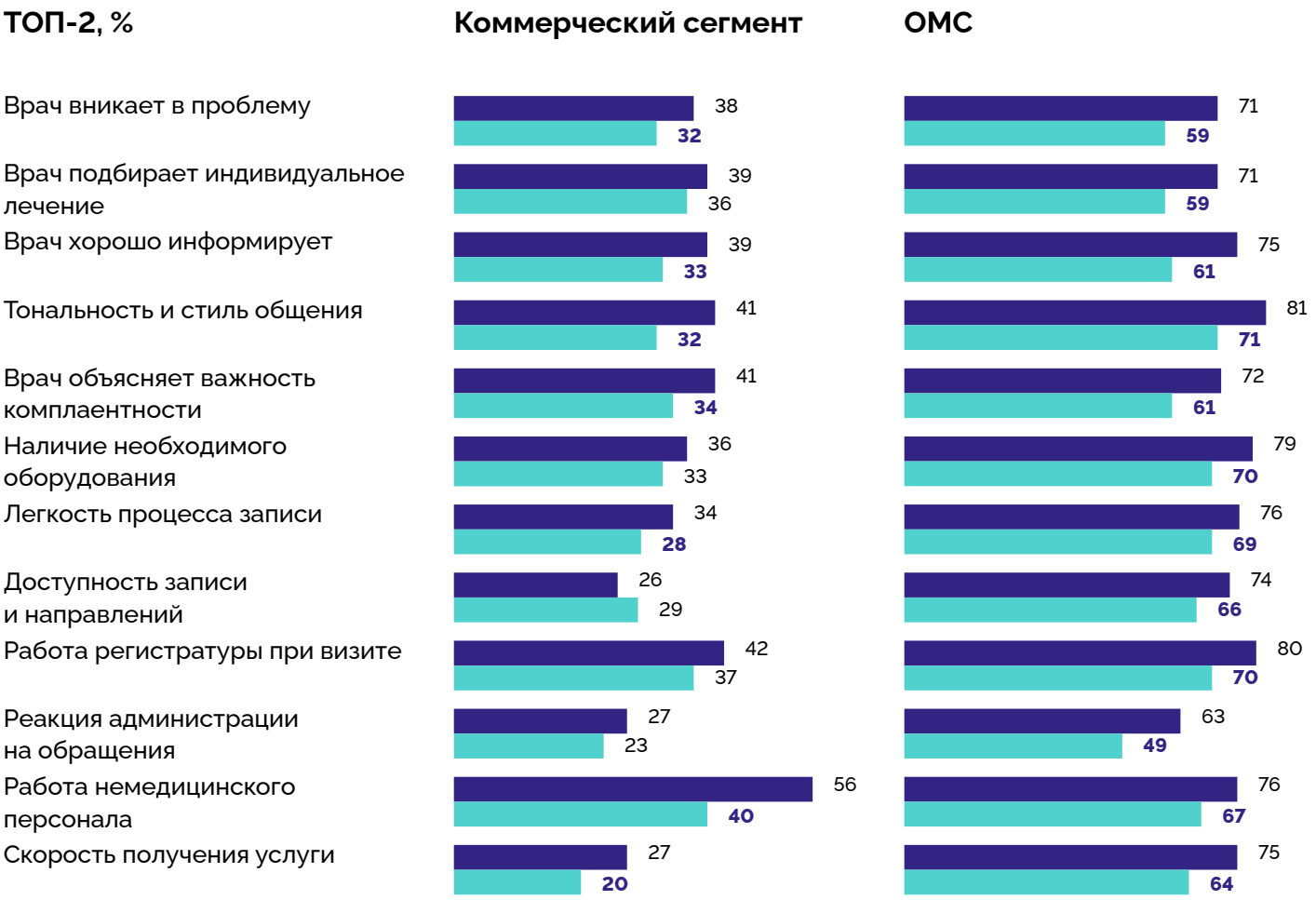
Восприятие работы системы здравоохранения (1/5)

При оценке ожиданий среди тех, кто не обращался, и опыта тех, кто обращался к амбулаторному врачу за последние 12 месяцев, как в ОМС, так и в коммерческом сегменте реальная работа системы здравоохранения по ключевым условиям успешного визита воспринимается лучше, чем ожидаемая оценка пациентами без опыта обращения.

Как ожидания, так и опыт взаимодействия с коммерческой сегментом С3 по всем параметрам выше, чем взаимодействие с сегментом ОМС.

Обращались к амбулаторному врачу за 12М

Не обращались к амбулаторному врачу за 12М



Восприятие работы системы здравоохранения (2/5)

При оценке ожиданий среди тех, кто не обращался, и опыта тех, кто обращался к амбулаторному врачу за последние 12 месяцев, как в ОМС, так и в коммерческом сегменте среди менее важных параметров реальная картина работы СЗ также оценивается выше, чем ожидания.

По большему количеству параметров коммерческая сегмент СЗ оценивается выше, чем сегмент ОМС. Однако разница оценок между сегментами менее важных параметрах меньше, чем на более важных условиях идеального визита к врачу.

Восприятие работы системы здравоохранения (3/5)

В зависимости от типа заболевания пациента разницы между оценками восприятия работы системы здравоохранения не выявлено.

Фокус на вопросах комплаентности - единственный параметр, по которому выявлена значимая разница ожиданий в зависимости от типа заболевания. Однако пациенты, которые посещали врача, оценивают этот параметр равноценно вне зависимости от типа заболевания.

Сохраняется тенденция выше оценивать систему здравоохранения пациентами, которые имели опыт обращения в течение последних 12 месяцев.

Обращались к амбулаторному врачу за 12М

Не обращались к амбулаторному врачу за 12М

Восприятие работы системы здравоохранения (4/5)

Среди менее важных параметров существенной разницы между оценками восприятия работы системы здравоохранения в зависимости от типа заболевания также не выявлено.

Пациенты, которые имели опыт обращения в течение последних 12 месяцев, выше оценивают работу системы здравоохранения.

Восприятие работы системы здравоохранения (5/5)

В зависимости от конкретного заболевания

Существенной разницы в оценке работы муниципальной СЗ в зависимости от конкретного заболевания не выявлено.

Однако пациенты с ССЗ и заболеваниями суставов отмечают более внимательное и эмпатичное отношение врача по отношению к себе и к своей проблеме (50-54%), а пациенты с СД отмечают высокую скорость получения необходимых услуг (39%).

В зависимости от тяжести состояния

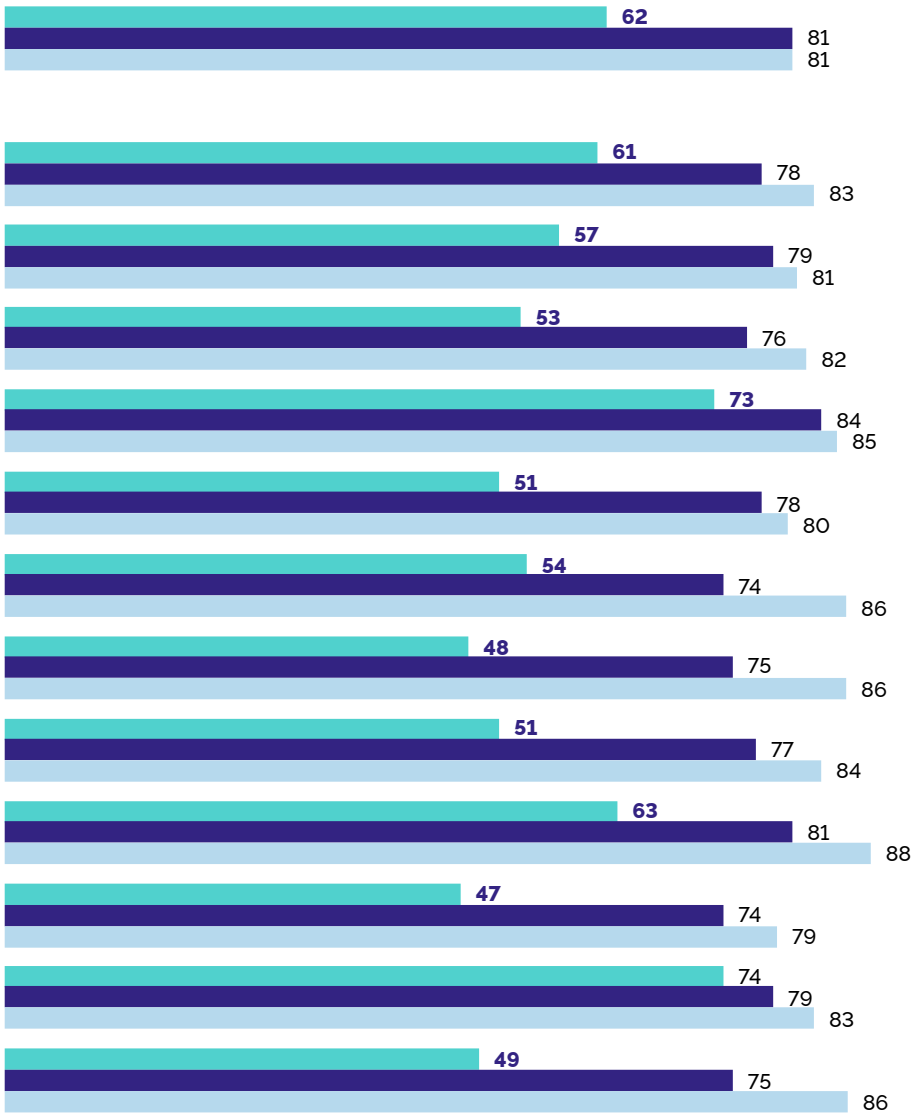
Пациенты с низкой и средней тяжестью состояния оценивают работу системы без значимой разницы.

Однако пациенты в тяжелом состоянии отмечают как более доброжелательное отношение к себе (83%), так и остро ощущают низкую скорость (36%) и доступность (33%) получения услуги.

Оценка системы здравоохранения (1/3)

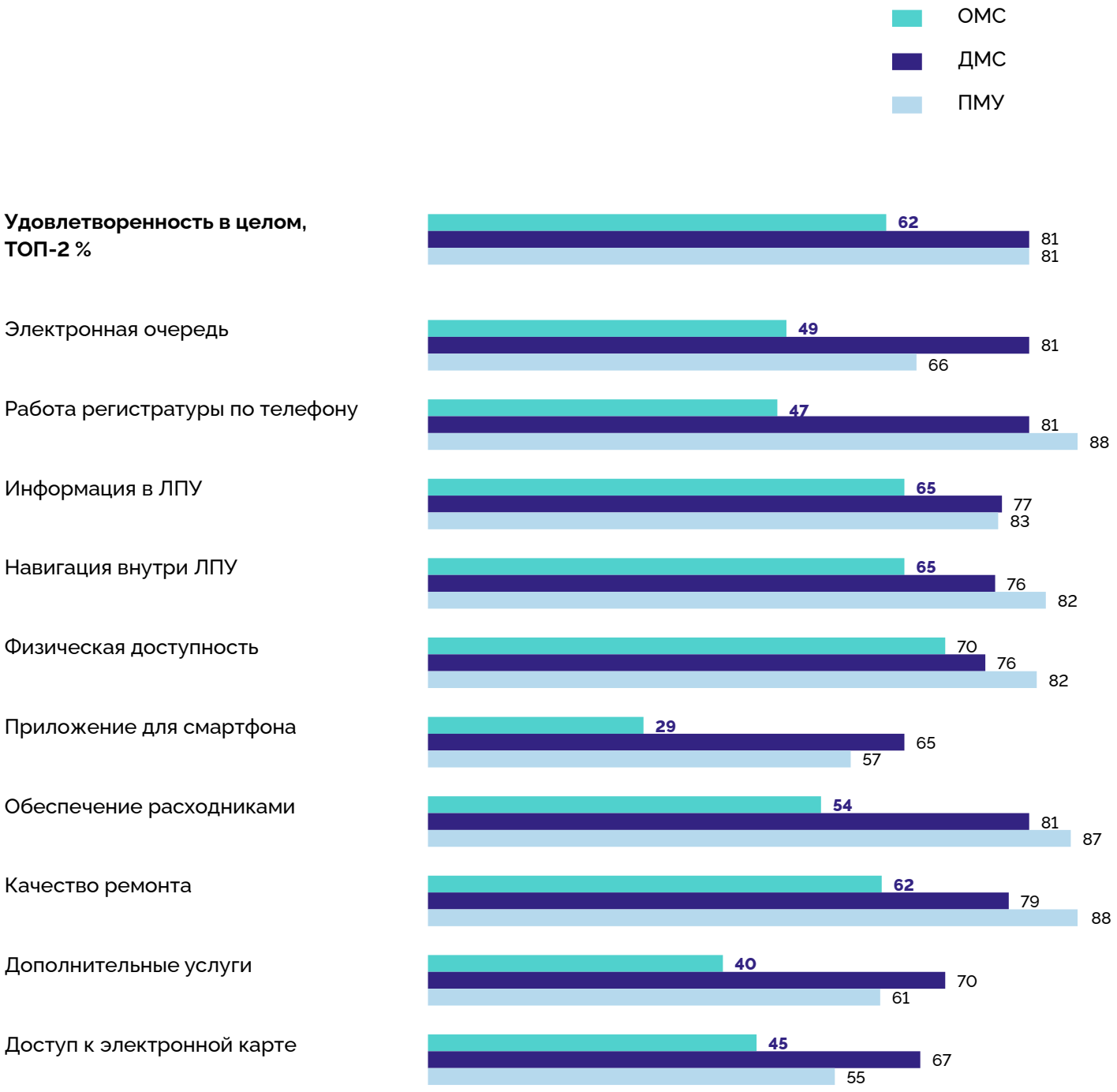
В целом, опыт использования по параметрам удовлетворенности коммерческой медицины и услугами ДМС оценивается одинаково (81%), но выше, чем сегмент ОМС (62%), в том числе и самый важный фактор - взаимодействие с врачом.

Обращает на себя внимание, что большинство ключевых параметров при оценке системы ОМС более половины пациентов оценивает положительно.



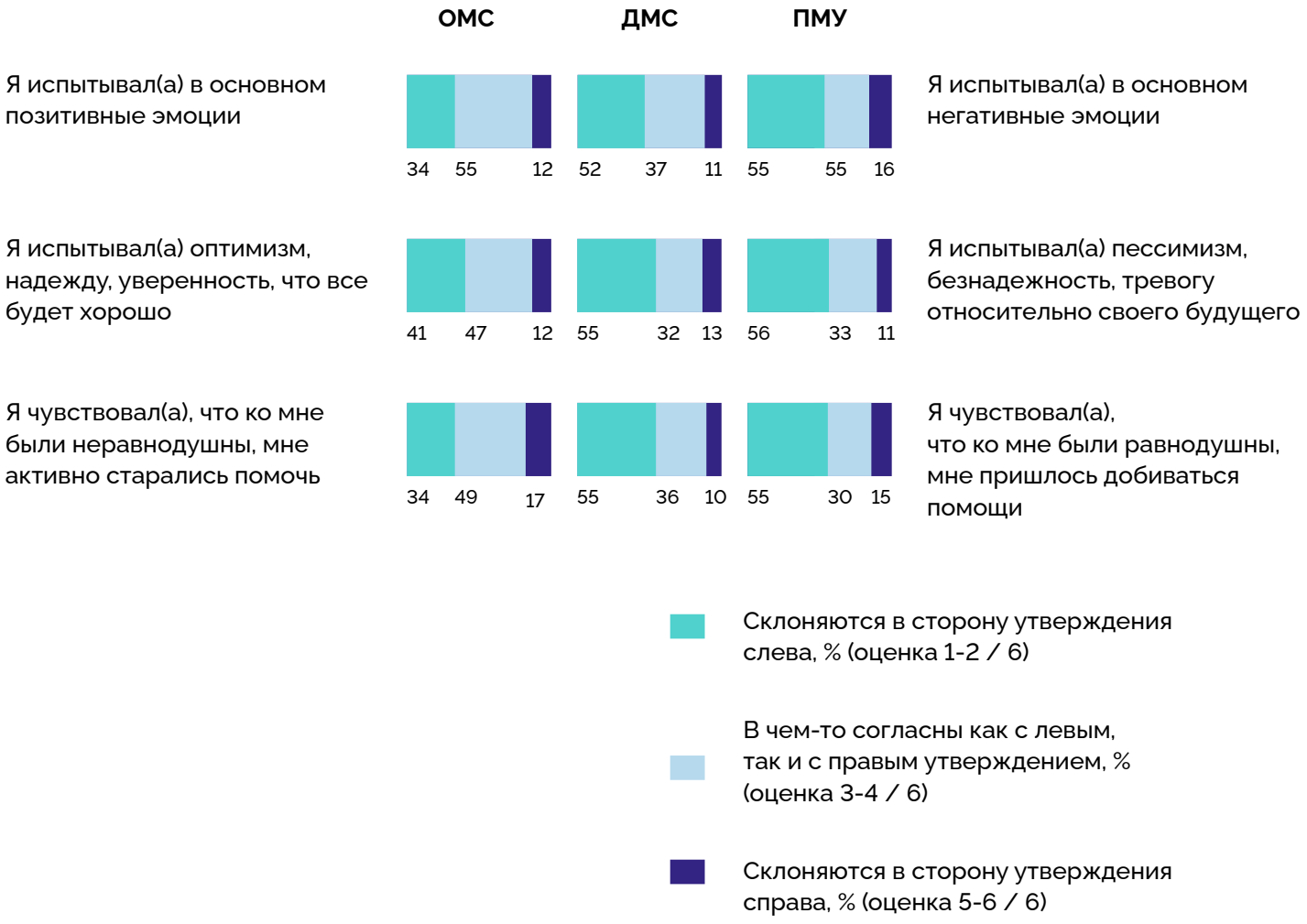
Оценка системы здравоохранения (2/3)

По менее важным параметрам удовлетворенности коммерческая медицина и сегмент ДМС оцениваются все еще выше, чем сегмент ОМС.



Оценка системы здравоохранения (3/3)

Пациенты, которые пользовались коммерческими услугами, испытывали больше положительных эмоций (54-56%), чем нейтральных (30-37%). В то время как пациенты, которые пользовались муниципальной медициной, испытывали больше нейтральные эмоции (47-55%), чем положительные (34-41%). Негативные эмоции (11-17%) редко встречались у всех сегментов С3.



Понимание пациентоцентричности

Пациентоцентричность: это решение проблемы, с которой обратился пациент, сострадание и включенность, диалог, хорошо налаженная обратная связь — возможность быстро, по понятному каналу обратиться с проблемой и получить оперативный ответ на свой вопрос.

Эмпатия и человекоцентричность — это следующий уровень развития системы: гуманная система, учитывающая потребности всех участников системы — и врачей, и пациентов.

Для меня пациентоцентричность — это решение проблемы пациента, а человекоцентричность – это когда к нему относятся как к человеку. И одно без другого существовать не может!

Пациент, профилактическое обращение

Подстройка именно под пациента, что важно именно для него. Кто-то раз в год ходит или вообще не ходит, обращается именно по проблеме. Кто-то ходит регулярно профилактически. Кто-то хочет, чтобы ему больше внимания уделили на приеме, а у кого-то есть пять минут и все.

Пациент, профилактическое обращение

Пирамида потребностей пациента

3
Идеальная ситуация

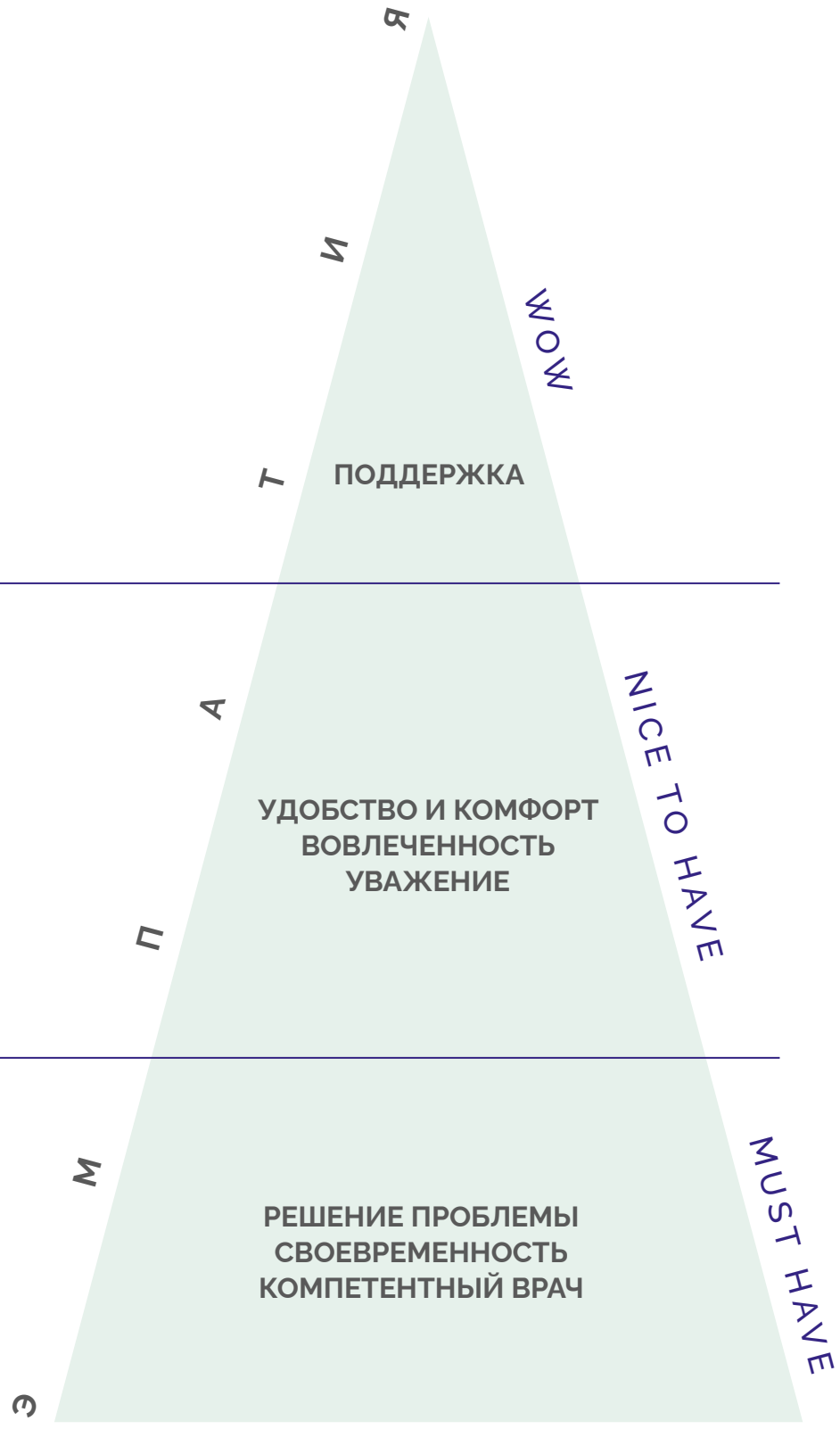
- Эмоциональная вовлеченность врача
- Индивидуализация подходов
- Многосторонняя поддержка
- Обеспечение максимального снятия стресса у пациента

2
Больше чем решение проблемы

- Вовлеченность врача – шире стандартов и протоколов
- Удобное, простое, быстрое решение проблемы
- Обеспечение базовых эмоциональных прав человека

1
Решение проблемы = получение помощи

- Компетентный врач
- Своевременно оказанная помощь
- Обеспечение «гигиенические» факторов



Карта эмоций пациента

Благодарность Уважение

Спасли
«Если бы не врачи, все было бы очень плохо»

Забота
«Выслушали, проявили внимание»

Радость
«Ничего себе как все изменилось, а я и не знала!»

Надежда
«И наконец выяснят, что со мной»

Чувство вины Страх

Брошенность
(стационар), «Врач не приходит к пациенту в течение дня, а то и двух, если это – выходные»

Неуверенность/ стыд
«Все нужно просить и надеяться, что пойдут на встречу»

Беспокойство
«Иду и не знаю как пройдет визит»

Тревожность
«Почему со мной это происходит?»

Вина
«Врач меня отругал»

Желание получить нужное
«Все приходится выбивать»

Брошенность
(стационар), «Врач не приходит к пациенту в течение дня, а то и двух, если это – выходные»

Раздражение Дискомфорт

Обида
«Отмахиваются от меня, зачем сидят тут, все равно ничего не знают»

Желание получить нужное
«Все приходится выбивать»

Надменность со стороны врача
«Врач был мной недоволен»

Собственная неуместность
«Врач говорит мне «Зачем вы пришли?»

Сожаление
«Жаль потраченного на бесполезный визит времени»

Сегменты пациентов (1/3)

Активность и Информированность о системе выше

Разбирающиеся эмоциональные 22%

Им важна всесторонняя поддержка

Более остро реагируют на все аспекты взаимодействия с системой, но готовы мириться с недостатками, если получают результат.

Компетентны в вопросах здоровья, могут более глубоко оценить работу врача и, как следствие, более склонны оценивать систему позитивно.

Нуждаются в расширенных опциях: комфорт, дружелюбие, особый подход, психологическая поддержка.

Разбирающиеся спокойные 27%

Им важно быстро решить проблему

У них нет особых эмоциональных потребностей, но если о них позаботятся, расценят как приятный бонус.

Они чувствуют себя в системе, понимают, как она работает.

Доверие системе самое высокое, редко могут обратиться за вторым мнением.

Чувствительность

Рациональность

Неразбирающиеся эмоциональные 32%

Им важна инициатива системы и процесс общения

Остро и негативно реагируют на систему, так как не могут рационально оценить ее работу.

Они ждут, чтобы система здравоохранения предлагала им что-то сама, а не только по их запросу.

Для них также важна коммуникация с врачом: общение, поделиться проблемой.

Доброжелательное отношение врача они воспринимают, как нетипичное, и это резко улучшает их пациентский опыт.

Неразбирающиеся спокойные 19%

Им важно получить эффективную помощь в острой ситуации

«Случайные гости» в системе здравоохранения, обращаются за медицинской помощью только по очень серьезным поводам.

Не особенно вовлечены в вопросы собственного здоровья, поэтому в целом удовлетворены имеющимися ресурсами.

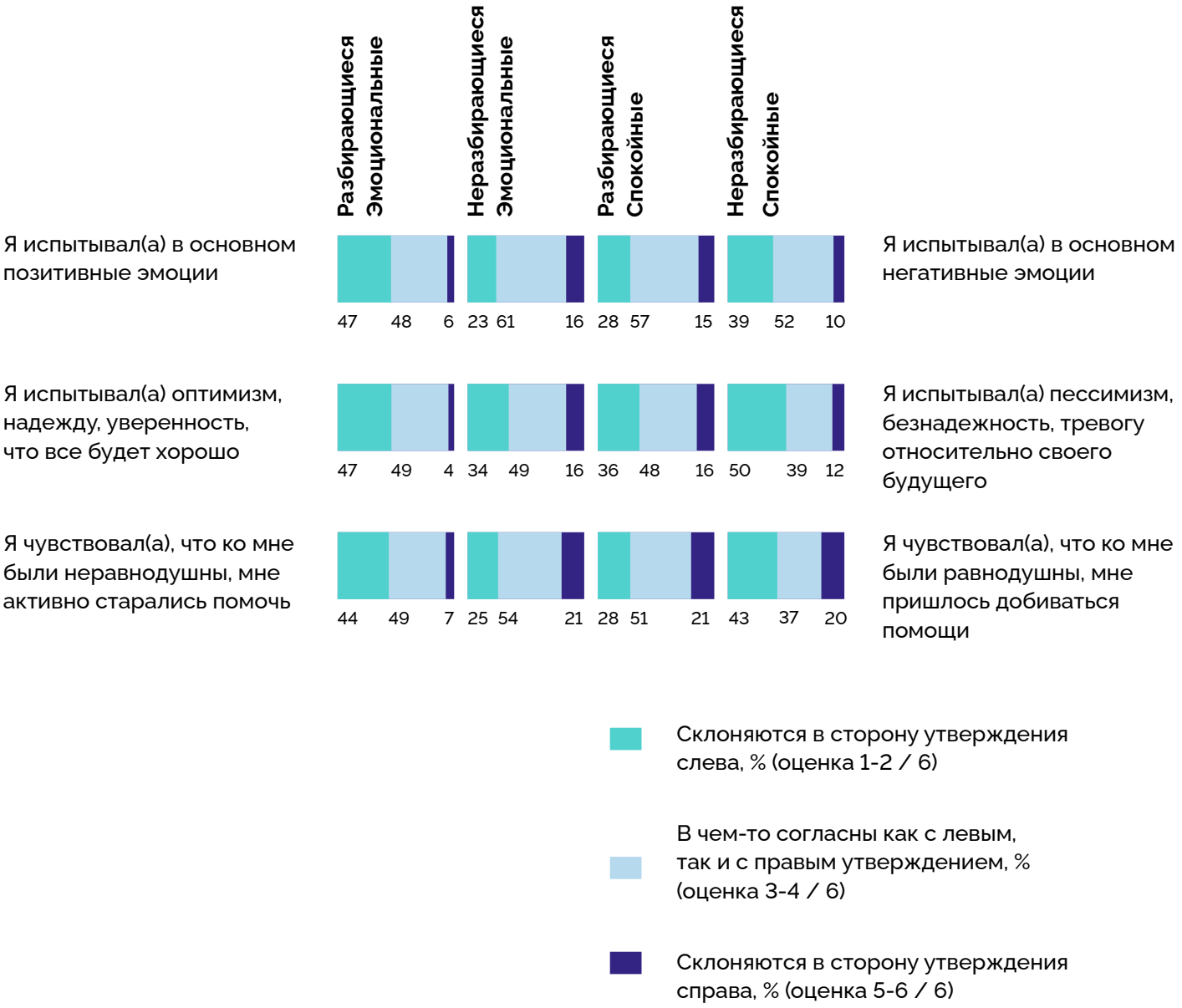
Активность и Информированность о системе выше

Сегменты пациентов и их удовлетворенность системой (2/3)

В целом, сложнее всего приходится эмоциональным пациентам, которые недостаточно разбираются в вопросах своего здоровья и недостаточно понимают суть врачебных рекомендаций, они демонстрируют самый низкий уровень удовлетворенности системой - 44%. С другой стороны, эмоциональные пациенты, которые разбираются в своем здоровье, напротив, чаще других довольны своим опытом и взаимодействием с врачом (75%). Спокойные пациенты представляют сбалансированную оценку системы здравоохранения (64-70%).

Сегменты пациентов (3/3)

«Разбирающиеся эмоциональные» пациенты склонны испытывать более позитивные эмоции (44-47%) в отличие от «неразбирающихся эмоциональных» пациентов (23-34%), которые преимущественно дают нейтральную оценку своему эмоциональному состоянию. «Разбирающиеся спокойные» и «неразбирающиеся спокойные» занимают срединную позицию, демонстрируя как позитивные, так и нейтральные реакции.



Острота восприятия проблемы и внимание к деталям

Заболевание	**Профилактическая цель посещения** Здоровым человеком	**Хроническое заболевание** Пациент постоянно в течение длительного времени посещает врачей	**Острая ситуация** Обращение с острыми симптомами, плохое самочувствие, страх и переживания	**Тяжелое заболевание, физические ограничения** Человек испытывает физические сложности и становится более чувствителен к деталям и комфорту/его недостатку
Звено	**Районная поликлиника** Привычное место и врач, которого хорошо знаешь и доверяешь ему	**Стационар (планово)** рутинное событие, пациент может подготовиться в бытовом плане и психологически	**Стационар (экстренно)** С острой проблемой, экстренно – когда пациент не имеет возможности подготовиться, ситуация внезапная	**Онкологическая клиника** Место, вызывающее у пациентов негативные эмоции и переживания. Как правило, пациент не сразу понимает маршрут, для него это не привычный поход к участковому терапевту
Тип пациента	**Рациональный, хорошо информированный** и вовлеченный в свое здоровье пациент, который легко ориентируется в системе СЗ и сам возьмет от нее все, что ему нужно	**Рациональный пациент, который не разбирается в здоровье** Без поддержки может потеряться и не сразу вникнуть, как и куда обращаться, что делать	**Чувствительный эмоциональный пациент** С острой проблемой, который начинает остро реагировать даже на малозначительные детали в спокойной ситуации	**Онкологический пациент** Им очень страшно, очень тяжело и больно. Каждая мелочь приобретает особое значение.

Рекомендованные зоны дальнейшего совершенствования системы здравоохранения

Положение врача в государственных медицинских учреждениях

Доступность диагностических услуг и специализированной помощи

Образ системы ОМС в обществе

Отношение пациентов к диспансеризации

Пациентоцентричность

Дальнейшее развитие пациентоцентричности напрямую зависит от положения врача и от его вовлеченности в процесс работы.

В государственных медицинских учреждениях врачи имеют больше нагрузка и потенциально меньше ресурсов для демонстрации их вовлеченности, чем в коммерческих медицинских учреждениях.

Основной поток пациентов проходит через государственные медицинские учреждения по ОМС

Восприятие системы здравоохранения оказывается лучше у тех пациентов, которые имели опыт взаимодействия как в ОМС, так и в коммерческом сегменте. По большему количеству параметров коммерческий сегмент СЗ оценивается выше, чем сегмент ОМС, включая вовлеченность врача.

Опыт взаимодействия пациента с СЗ в первую очередь зависит от компетентности и отзывчивости врача, и в меньшей степени от скорости получения услуги и доступного медицинского оборудования. Только при соблюдении этих условий пациент обращает внимание на технические аспекты взаимодействия с системой.

Доступность услуг

Большая часть пациентов ввиду долгого ожидания получения медицинских услуг по системе ОМС, обращается за платными медицинскими услугами, как для визита к врачу (чаще узкоспециализированному), так и для получения диагностических услуг.

3 из 5 пациентов обращаются за платными диагностическими услугами, а каждый четвертый пациент оплачивал прием у врача за последние 12 месяцев

Основная причина, по которой приходится платить - долгое ожидание получения услуг по ОМС.

При платном визите к врачу пациенты чаще записываются к врачам узких специальностей, чем при посещении по ОМС и ДМС

~50%

обращений по ОМС и ДМС — это обращения к врачу-терапевту, реже к врачам узких специальностей.

Бесшовный переход

Несмотря на высокий уровень цифровизации в стране, передача данных в рамках системы здравоохранения все еще разрознена.

В целом, сегмент ОМС нельзя назвать проактивным в вопросах рекомендаций альтернативных услуг, однако в более маленьких городах система более «отзывчива».

Каждый пятый пациент совмещал несколько видов страхования (чаще ОМС+ПМУ) в рамках лечения одного случая.

Основная причина комбинирования – долгое ожидание врача или диагностической услуги по ОМС.

В половине случаев обращение к платной системе – это инициатива пациента, который вынужден самостоятельно разбираться с тем, что делать дальше.

Необходимость передать результаты диагностики от системы к системе возникает в 60% случаев. Врач должен вносить данные в бумажную или электронную карту, что приводит к потере результатов в каждом пятом случае.

Диспансеризация

Профилактика – способ снизить нагрузку на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе, а также улучшить опыт пациентов.

Городские программы диспансеризации недостаточно популярны, несмотря на их известность. Возможной причиной их невысокой распространенности может являться недостаточная вовлеченность врача в процесс.

30%

взрослых обращались к врачу для профилактики. Среди обращавшихся в большинстве случаев пациент сам решает, к какому специалисту обратиться.

38%

обращавшихся взрослых пользовались городской программой профилактики, преимущественно в Москве.

Значимая часть пациентов знает о существовании программ диспансеризации, однако только менее половины осведомленных проходит диспансеризацию.

Уровень удовлетворенности визитом в рамках самостоятельной диспансеризации выше, чем в рамках городской программы диспансеризации

Эмоциональный аспект

Возвращение пациенту чувства контроля над ситуацией – очень важный шаг для улучшения опыта взаимодействия с СЗ.

При взаимодействии с СЗ также необходимо учитывать и эмоциональный аспект пациента. Эмоциональные пациенты дают более яркую оценку системы здравоохранения, а спокойные, в свою очередь, более нейтральную.

В зависимости от того насколько визит к врачу влияет на эмоциональное состояние человека, и того, насколько он разбирается в вопросах здоровья, мы выделили четыре сегмента взрослых, которые по разному реагируют на СЗ

Эмоциональные пациенты, которые не разбираются в вопросах здоровья, редко бывают удовлетворены своим опытом обращения к муниципальному врачу. Эмоциональные разбирающиеся пациенты, наоборот, оценивают свои визиты к врачу позитивно.

Спокойные пациенты показывают нейтральную или нейтрально-позитивную реакцию на государственную медицину независимо от того, разбираются ли они в вопросах здоровья или нет

Дальнейшие шаги развития

Забота как о пациенте, так и о враче, созданиепартнерских отношений

Единая электронная система с результатами медицинских услуг, доступная каждому пациенту

Работа над тремя уровнями пирамиды потребностей: доступность услуг, вовлеченность врача и индивидуальный подход

Повышение доступности медицинских услуг — диагностических и врачей узких специалистов.

Повышение доступности медицинских услуг, разработка алгоритмов и маршрутов по различным нозологиям.

Развитие диспансеризации, повышение заинтересованности в профилактике и пациента, и врача

Улучшение имиджа системы ОМС и широкое информирование о позитивных изменениях и доступных возможностях

Учет эмоционального аспекта пациента при взаимодействии с СЗ, создание чувства контроля над ситуацией

Авторы исследования

ВЕЛДАНОВА Марина

Профессор практики, директор Центра развития здравоохранения Школы управления СКОЛКОВО, доктор медицинских наук

БЕЗУГЛОВА Марина

Исполнительный директор IPSOS в России, кандидат медицинских наук

КРАСИЛЬНИКОВА Елизавета

Научный сотрудник Центра развития здравоохранения Школы управления СКОЛКОВО

РОМАНЕНКО Светлана

Руководитель направления количественных исследований Healthcare Custom, IPSOS в России

ЖУРАВЛЕВА Марина

Старший консультант направления качественных исследований Healthcare Custom, IPSOS в России